

**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ.**



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τμήμα Ιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ



**ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

Φλώρινα, Ιανουάριος 2025

Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Θεοδώρα Παπαμήτσου για τη σημαντική συμβολή της τόσο στην επιλογή του θέματος όσο και στη διαδικασία επίβλεψης καθώς και τον κύριο Σταύρο Χεριστανίδη για την συμβολή του στη σωστή δόμηση της παρούσας εργασίας . Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλλαν στην διεξαγωγή του μεταπτυχιακού προγράμματος, καθώς πρόσφεραν σημαντικές γνώσεις και ευαισθητοποίησαν τους φοιτητές σε θέματα τόσο ιατρικού όσο και περιβαλλοντικού περιεχομένου.

Μεταπτυχιακή εργασία του: Στέφανου Χρηστίδη

Έτος έκδοσης 2025

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. ©

«Η έγκριση της διπλωματικής εργασίας από το πρόγραμμα δεν υποδηλώνει απαραίτητως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος. »

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία μελετάτε το πως οι περιβαλλοντικές αλλαγές και καταστροφές μπορούν να έχουν άμεση επίδραση στη ψυχική υγεία των ανθρώπων. Αρχικά παρουσιάζεται ο όρος της πλανητικής υγείας, ο οποίος εφευρέθηκε με σκοπό να αντιμετωπιστεί η υποβάθμιση που δέχεται το περιβάλλον και ο όρος της ψυχικής υγείας, που αναφέρεται στην ακεραιότητα και την ευημερία της ψυχολογικής και της συναισθηματικής κατάστασης ενός ατόμου. Στη συνέχεια γίνεται μια σύνδεση των δύο αυτών όρων και προκύπτει ότι η πλανητική υγεία και η ψυχική υγεία είναι δυο όροι που αλληλοσυμπληρώνονται. Τέλος το κυρίως μέρος τις εργασίας επικεντρώνεται στις ψυχικές διαταραχές που μαστίζουν στην εποχή μας. Η εμφάνιση των οποίων έχει άμεση σχέση με τις περιβαλλοντικές καταστροφές.

Λέξεις Κλειδιά

Πλανητική Υγεία

Ψυχική Υγεία

Κλιματική Αλλαγή

Ρύπανση

Κοινωνικές Ανισότητες

Οικολογικό Πένθος

Ψυχολογική Ευημερία

Ψυχικές Διαταραχές

Summary

In this paper, we examine how environmental changes and disasters can have a direct impact on people's mental health. Initially, the term "planetary health" is introduced, which was coined to address the degradation of the environment, alongside the term "mental health," which refers to the integrity and well-being of an individual's psychological and emotional state. Subsequently, a connection is established between these two terms, demonstrating that planetary health and mental health are two interrelated and complementary concepts. Finally, the main part of the paper focuses on the mental disorders that plague our era, whose emergence is directly linked to environmental disasters.

Keywords:

Planetary Health

Mental Health

Climate Change

Pollution

Social Inequalities

Ecological Grief

Psychological Well-being

Mental Disorders

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή.....	6
Πρόλογος.....	7
1. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ	8
1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.....	8
1.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	9
1.3 ΣΧΕΣΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	10
1.3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.....	10
1.3.2 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ.....	10
1.3.3 ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ	11
1.3.4 ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ	11
1.3.5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ	12
1.3.6 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ	12
2. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	13
2.1.1 ΒΑΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ.....	14
2.1.2 ΟΞΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΡΕΣ (ACUTE STRESS DISORDER, ASD)	15
2.1.3 ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ (POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER, PTSD).....	16
2.1.4 ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (ADJUSTMENT DISORDER).....	17
2.1.5 SOLASTALGIA	17
2.1.6 ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΓΧΩΔΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (GENERALIZED ANXIETY DISORDER, GAD).....	18
2.1.7 ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ.....	19
2.1.8 ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΑΝΙΚΟΥ (PANIC DISORDER).....	23
2.1.9 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΠΝΟΥ.....	25
2.1.10 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.....	26
2.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΑΣΤΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ.	28
2.2.1 Ο ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ.....	28
2.2.2 Ο ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΔΕΑΣΜΟΣ - ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ.....	29
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.	31
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....	33

Εισαγωγή

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της πλανητικής υγείας και της ψυχικής υγείας, εστιάζοντας στους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις ψυχικές διαταραχές. Επιπλέον, επιδιώκεται η ανάδειξη των προτάσεων και στρατηγικών που μπορούν να εφαρμοστούν για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των αρνητικών ψυχολογικών επιπτώσεων που σχετίζονται με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Μέσω αυτής της ανάλυσης, η εργασία στοχεύει να συμβάλει στην ευρύτερη κατανόηση της σημασίας της προστασίας του περιβάλλοντος για τη διασφάλιση της ψυχικής ευημερίας. Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο αγγλική βιβλιογραφία που με τη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης έγινε μετάφραση αυτών των κειμένων με σκοπό την όσο τον δυνατόν καλύτερη κατανόηση της σύνδεσης που υπάρχει ανάμεσα σε ψυχική και περιβαλλοντική υγεία. Το βασικότερο εμπόδιο στην όλη μελέτη ήταν η έλλειψη Ελληνικής βιβλιογραφίας επι του θέματος.

Πρόλογος

Η πλανητική υγεία, ένας σχετικά νέος αλλά ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας της επιστήμης, ενσωματώνει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ανθρώπων και των φυσικών συστημάτων που υποστηρίζουν τη ζωή στη Γη. Εστιάζει στην κατανόηση των συνθηκών που προάγουν την ανθρώπινη υγεία στο πλαίσιο της διατήρησης της βιωσιμότητας των οικοσυστημάτων. Η ψυχική υγεία, από την άλλη, είναι ένα πολύπλοκο πεδίο που επηρεάζεται από πολυάριθμους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών συνθηκών.

Καθώς η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει αυξανόμενες περιβαλλοντικές προκλήσεις, οι επιπτώσεις αυτών των αλλαγών στην ψυχική υγεία γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές. Η παρούσα εργασία εξετάζει διεξοδικά τη σχέση μεταξύ της πλανητικής υγείας και της ψυχικής υγείας, με στόχο να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους οι περιβαλλοντικές αλλαγές επιδρούν στην ψυχολογική ευημερία των ανθρώπων. Η ανάλυση αυτή είναι κρίσιμη για τους φοιτητές και τους επαγγελματίες υγείας που επιδιώκουν να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τις προκλήσεις που απορρέουν από τη συσχέτιση αυτή.

1. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η πλανητική υγεία είναι ένας διεπιστημονικός τομέας που εξετάζει τη διατήρηση της ανθρώπινης υγείας στο πλαίσιο της διατήρησης των φυσικών οικοσυστημάτων που υποστηρίζουν τη ζωή στη Γη. Στην ουσία, πρόκειται για μια ευρεία έννοια που περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση της δημόσιας υγείας με την οικολογία, την οικονομία και την κοινωνική επιστήμη, επιδιώκοντας να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει τις αρνητικές επιπτώσεις των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Η πλανητική υγεία αναγνωρίζει ότι η ανθρώπινη ευημερία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την υγεία του πλανήτη και ότι οι απειλές για τα οικοσυστήματα της Γης είναι ταυτόχρονα απειλές για την ανθρώπινη υγεία. (Lancet Psychiatry 2021).

Η έννοια αυτή αναδύθηκε από την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι πολύπλοκες και αλληλοσυνδεόμενες προκλήσεις που προκύπτουν από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, όπως η κλιματική αλλαγή, η εξάντληση των φυσικών πόρων και η απώλεια βιοποικιλότητας. Η πλανητική υγεία επιδιώκει να προάγει πολιτικές και πρακτικές που όχι μόνο θα διατηρούν την ανθρώπινη υγεία αλλά και θα προστατεύουν τα οικοσυστήματα από τα οποία εξαρτάται αυτή η υγεία (Lancet Psychiatry 2021).

Η κατανόηση της πλανητικής υγείας απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση που ενσωματώνει τη γνώση από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους. Σύμφωνα με μελέτη το 2015 που δημοσιεύθηκε στο The Lancet, η πλανητική υγεία βασίζεται στην αναγνώριση ότι η ανθρώπινη υγεία δεν μπορεί να διαχωριστεί από την υγεία των οικοσυστημάτων και ότι οι απειλές για τη βιωσιμότητα του πλανήτη, όπως η κλιματική αλλαγή και η περιβαλλοντική υποβάθμιση, αποτελούν ταυτόχρονα και απειλές για την ανθρώπινη υγεία (Whitmee, S., Haines, A., Beyrer, C., et al. 2015).

1.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η ψυχική υγεία αναφέρεται στην ακεραιότητα και την ευημερία της ψυχολογικής και της συναισθηματικής κατάστασης ενός ατόμου. Ένα ψυχικά υγιές άτομο είναι σε θέση να αξιοποιεί τις δυνατότητές του, να διαχειρίζεται το άγχος της καθημερινής ζωής, να εργάζεται παραγωγικά και να συνεισφέρει στην κοινότητά του. Η ψυχική υγεία δεν είναι απλώς η απουσία ψυχικών διαταραχών, αλλά περιλαμβάνει επίσης τη συνολική ευημερία του ατόμου, η οποία επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες, όπως βιολογικούς, κοινωνικούς, ψυχολογικούς και περιβαλλοντικούς (WHO, 2005).

Ως ορισμός της υγείας προκύπτει ότι. Υγεία είναι η πλήρης σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία του κάθε ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας Π.Ο.Υ). Από την άλλη μεριά η κοινωνική υγεία προάγει τη ζωτικότητα της κοινότητας και συνεπώς την ανάγκη να ορισθεί η υγεία βάση κοινωνικών όρων (Nies and McEwen, 2001).

Η ψυχική υγεία αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της συνολικής υγείας και ευημερίας των ανθρώπων. Η διατήρησή της απαιτεί ένα συνδυασμό υγιών κοινωνικών σχέσεων, επαρκούς υποστήριξης από το κοινωνικό περιβάλλον, και την ικανότητα να ανταπεξέρχεται κανείς στις προκλήσεις της ζωής. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική υγεία είναι πολλοί και ποικίλοι, με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες να παίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο (WHO 2005).

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η ψυχική υγεία είναι θεμελιώδης για την ικανότητα ενός ατόμου να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις της ζωής. Επιπλέον, έρευνες δείχνουν ότι η καλή ψυχική υγεία συνδέεται με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση της νοσηρότητας από άλλες ασθένειες . (Herrman, H., Saxena, S., & Moodie, R. 2014).

1.3 ΣΧΕΣΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

1.3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η πλανητική υγεία και η ψυχική υγεία είναι έννοιες που αλληλοσυμπληρώνονται, επηρεάζοντας η μία την άλλη μέσω μιας ποικιλίας μηχανισμών. Η πλανητική υγεία αφορά την προστασία και τη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων που υποστηρίζουν τη ζωή στη Γη, ενώ η ψυχική υγεία επικεντρώνεται στην ψυχολογική και συναισθηματική ευημερία του ατόμου. Οι επιπτώσεις των περιβαλλοντικών αλλαγών στην ψυχική υγεία είναι πολυεπίπεδες και επιφέρουν τόσο άμεσες επιπτώσεις, όπως η τραυματική εμπειρία από φυσικές καταστροφές, όσο έμμεσες επιδράσεις, όπως η αύξηση του άγχους και της αβεβαιότητας για το μέλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

1.3.2 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Οι φυσικές καταστροφές, όπως οι τυφώνες, οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές και οι ξηρασίες, έχουν ενταθεί τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αυτές οι καταστροφές δεν προκαλούν μόνο σωματικές ζημιές και υλικές απώλειες, αλλά επίσης επιβαρύνουν σοβαρά την ψυχική υγεία των ανθρώπων που πλήττονται. Τα άτομα που βιώνουν τέτοιες καταστροφές συχνά αναπτύσσουν μετατραυματικό στρες (PTSD), άγχος και κατάθλιψη, ειδικά όταν οι καταστροφές αυτές οδηγούν σε απώλεια περιουσίας, μετατόπιση ή ακόμα και θάνατο αγαπημένων προσώπων.

Σύμφωνα με έρευνες, η έκθεση σε τέτοιες τραυματικές εμπειρίες μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, ιδιαίτερα όταν οι καταστροφές είναι συχνές ή έντονες. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Clinical Psychiatry έδειξε ότι οι επιζώντες από φυσικές καταστροφές έχουν αυξημένο κίνδυνο για την ανάπτυξη PTSD και άλλων ψυχικών διαταραχών. Η συσσώρευση τέτοιων εμπειριών μπορεί να προκαλέσει "σωρευτική τραυματική εμπειρία", όπου η ικανότητα των ατόμων να προσαρμοστούν σε μελλοντικές καταστάσεις κρίσης μειώνεται σημαντικά (Journal of Clinical Psychiatry, 2019).

1.3.3 ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Η ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους έχει επίσης σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Οι άνθρωποι που εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα ρύπανσης συχνά παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για την ανάπτυξη ψυχικών διαταραχών, όπως το άγχος και η κατάθλιψη. Η ατμοσφαιρική ρύπανση, συγκεκριμένα, έχει συνδεθεί με την επιδείνωση της ψυχικής υγείας. Έρευνες δείχνουν ότι η μακροχρόνια έκθεση σε λεπτά σωματίδια (PM_{2.5}) μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για ψυχικές διαταραχές, καθώς και για νευρολογικές ασθένειες όπως η νόσος Αλτσχάιμερ .

Η ηχορύπανση αποτελεί επίσης σημαντικό περιβαλλοντικό παράγοντα που επηρεάζει την ψυχική υγεία. Η συνεχής έκθεση σε θόρυβο μπορεί να προκαλέσει χρόνιο στρες, διαταραχές ύπνου και αυξημένο άγχος, επηρεάζοντας αρνητικά την ποιότητα ζωής. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο *Environmental Health Perspectives* έδειξε ότι η ηχορύπανση σε αστικές περιοχές μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης και άλλων ψυχικών διαταραχών (*Environmental Health Perspectives*, 2020).

1.3.4 ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Η απώλεια βιοποικιλότητας, δηλαδή η εξαφάνιση ειδών και η υποβάθμιση οικοσυστημάτων, έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των ανθρώπων. Πολλοί άνθρωποι αναπτύσσουν συναισθήματα λύπης, πένθους και απόγνωσης λόγω της καταστροφής των φυσικών οικοσυστημάτων που γνώριζαν. Αυτό το φαινόμενο, γνωστό ως "οικολογικό πένθος", μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ψυχικές διαταραχές, όπως η κατάθλιψη και το άγχος.

Η σχέση των ανθρώπων με τη φύση είναι βαθιά ριζωμένη στην ψυχολογία τους. Η παρουσία και η εμπειρία του φυσικού περιβάλλοντος έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει στη μείωση του άγχους και στην ενίσχυση της ψυχολογικής ευεξίας. Όταν οι άνθρωποι χάνουν αυτή τη σύνδεση λόγω της απώλειας βιοποικιλότητας, μπορεί να αντιμετωπίσουν συναισθηματική και ψυχολογική δυσφορία. Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο *American Journal of Public Health* υποστηρίζει ότι η διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ψυχικής υγείας και ευεξίας (*American Journal of Public Health*, 2018).

1.3.5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Οι κοινωνικές ανισότητες επιδεινώνονται λόγω των περιβαλλοντικών προβλημάτων, και αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των ευάλωτων ομάδων. Οι φτωχότερες κοινότητες και οι περιθωριοποιημένες ομάδες είναι συχνά οι πρώτες που πλήττονται από τις περιβαλλοντικές κρίσεις, όπως η κλιματική αλλαγή και η ρύπανση. Αυτή η αδικία και η αίσθηση ανημποριάς μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο άγχος, κατάθλιψη και άλλα ψυχικά προβλήματα.

Η κλιματική αλλαγή προκαλεί επίσης μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, οι οποίες επιδεινώνουν τις κοινωνικές ανισότητες και δημιουργούν νέες προκλήσεις για την ψυχική υγεία. Οι μετανάστες που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους λόγω περιβαλλοντικών καταστροφών αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για ψυχικές διαταραχές λόγω της απώλειας οικίας, κοινωνικών δικτύων και πολιτιστικής ταυτότητας (Clayton, S., Manning, C. M., & Hodge, C. 2014).

Ψυχολογικές Επιπτώσεις της Περιβαλλοντικής Αλλαγής στα Παιδιά και τους Εφήβους

Τα παιδιά και οι έφηβοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις ψυχικές επιπτώσεις των περιβαλλοντικών αλλαγών. Η έκθεση σε ακραία καιρικά φαινόμενα και σε άλλες περιβαλλοντικές καταστροφές μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ψυχικές διαταραχές σε αυτές τις ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων του άγχους, της κατάθλιψης και του PTSD. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο *Lancet Psychiatry* υπογραμμίζει ότι τα παιδιά που εκτίθενται σε τέτοιες συνθήκες αναπτύσσουν συχνά μακροχρόνιες ψυχικές διαταραχές, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την ανάπτυξη και την ευημερία τους (*Lancet Psychiatry*, 2021)

1.3.6 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ

Παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της περιβαλλοντικής υποβάθμισης στην ψυχική υγεία, η επαφή με τη φύση μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρό εργαλείο για την ενίσχυση της ψυχολογικής ευεξίας. Η συμμετοχή σε δραστηριότητες στη φύση, όπως η πεζοπορία, η κηπουρική ή η απλή παραμονή σε πράσινους χώρους, έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το άγχος και την κατάθλιψη, ενώ ενισχύει τη συνολική ψυχολογική ευημερία. Η "οικοθεραπεία" (ecotherapy) είναι μια αναδυόμενη προσέγγιση που χρησιμοποιεί τη φύση ως μέσο θεραπείας για την ψυχική υγεία.

2. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Οι ψυχικές διαταραχές και οι διαταραχές τις συμπεριφοράς είναι κοινές και έχουν επηρεάσει περισσότερο από το 25% των ανθρώπων κάποια στιγμή στη ζωή τους. Επίσης είναι φανερό ότι προσβάλλουν κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης. Περίπου 20% των ανθρώπων που εξετάζονται από γιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδας, έχουν μια ή περισσότερες διαταραχές. Με αποτέλεσμα μια στις τέσσερις οικογένειες είναι πιθανό να έχει ένα μέλος με ψυχικές διαταραχές. (ΠΕΤΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, 2017).

Υπολογίζεται ότι το 4,4% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχουν από καταθλιπτική διαταραχή και 3,6% από αγχώδη διαταραχή. Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων όλων των ηλικιών που ζουν με κατάθλιψη στον κόσμο είναι 322 εκατ. (αυξήθηκε κατά 18,4% μεταξύ 2005- 2015). Η κατάθλιψη είναι μια από τις κύριες αιτίες αναπηρίας στον κόσμο (ΠΕΤΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, 2017). Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, το 2024 περίπου 5% των ενηλίκων παγκοσμίως πάσχουν από καταθλιπτική διαταραχή (WHO, 2024).

Οι αγχώδεις διαταραχές κατατάσσονται ως η έκτη μεγαλύτερη αιτία απώλειας της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο συνολικός εκτιμώμενος αριθμός των ανθρώπων με διαταραχές άγχους στον κόσμο είναι 264.000.000 (αυξήθηκε κατά 14,9% από το 2005 έως το 2015). (ΠΕΤΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, 2017).

Μέχρι το 2020, ο παγκόσμιος αριθμός των ανθρώπων που υπέφεραν από αγχώδεις διαταραχές αυξήθηκε σημαντικά λόγω της πανδημίας COVID-19, με εκτιμώμενες 374 εκατομμύρια περιπτώσεις. Αυτή η αύξηση αντιπροσώπευε μια αύξηση της τάξεως του 27,9% σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την πανδημία, όταν ο αριθμός των περιστατικών ανερχόταν περίπου σε 264 εκατομμύρια το 2019 (THE LANCET, 2021), (Nina Julia, 2023).

Κατά το έτος 2015, εκτιμάται ότι περίπου 800.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω αυτοκτονίας και πολλοί περισσότεροι αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν. Ποσοστό που αντιπροσωπεύει περίπου το 1,5% όλων των θανάτων παγκοσμίως (βασική αιτία θανάτου το 2015). Ήταν η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου ηλικιών μεταξύ 15-29 ετών σε παγκόσμιο επίπεδο το 2015. (ΠΕΤΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, 2017). Ωστόσο μέχρι το 2024, η αυτοκτονία συνεχίζει να αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες θανάτου για τους νέους ηλικίας 15-29 ετών. Αν και τα παγκόσμια ποσοστά αυτοκτονιών έχουν σημειώσει μικρές μειώσεις, η αυτοκτονία παραμένει η τέταρτη κύρια αιτία θανάτου σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, σε σύγκριση με τη δεύτερη θέση που κατείχε το 2015 (Suicide rate, 2021).

Η μείωση αυτή οφείλεται σε κάποιες προληπτικές δράσεις που έχουν ληφθεί, ωστόσο σε πολλές χώρες τα ποσοστά παραμένουν σταθερά ή και αυξάνονται, ειδικά σε περιοχές με υψηλά επίπεδα κοινωνικοοικονομικού στρες και ανεπαρκείς υποδομές ψυχικής υγείας.

2.1.1 ΒΑΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ.

Στις μέρες μας είναι ευρέως γνωστό ότι ο πλανήτης αντιμετωπίζει περιβαλλοντική κρίση. Οι αυξανόμενες αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον αποτελούν την απόδειξη όλων όσων οι επιστήμονες προειδοποιούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Με αποτέλεσμα τη δεδομένη στιγμή ο πλανήτης να αντιμετωπίζει σοβαρές περιβαλλοντικές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή η ρύπανση και η καταστροφή της βιοποικιλότητας (Clayton et al., 2017).

Όλες αυτές οι αλλαγές και οι καταστροφές που υφίσταται ο πλανήτης έχουν άμεση επίδραση στην ανθρωπότητα. Με αποτέλεσμα να διαταράσσεται τόσο η σωματική όσο και η ψυχολογική ευημερία των ανθρώπων. Οι φυσικές καταστροφές δύναται να επιδεινώσουν προϋπάρχουσα ψυχοπαθολογία ή να προκαλέσουν την εκδήλωση ψυχολογικής δυσφορίας και ψυχιατρικών διαταραχών ως έντονα τραυματικά γεγονότα (ΠΕΤΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, 2017).

Αυτές οι αλλαγές έχουν πυροδοτήσει μια αυξανόμενη ανησυχία για το πώς οι περιβαλλοντικές αλλαγές επηρεάζουν τη ψυχική υγεία και τη κοινωνική συμπεριφορά. Με τον όρο ψυχολογία του περιβάλλοντος η επιστημονική κοινότητα εξετάζει τη δυναμική διασύνδεση ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον και τη ψυχολογία των ανθρώπων, δίνοντας έμφαση στις γνωστικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές αντιδράσεις (Steg et al., 2018).

Μια πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία που προέρχεται από τη κοινωνιολογία και μπορεί να συσχετιστεί και να εξηγήσει το πως μια περιβαλλοντική αλλαγή μπορεί να προκαλέσει μια ψυχική διαταραχή, είναι η θεωρία γνωστή ως 'Το φαινόμενο πεταλούδας'. Το φαινόμενο αυτό, που προέρχεται από τη θεωρία του Χaos της μη γραμμικότητας, υπαινίσσεται ότι μικρές αλλαγές σε ένα σύστημα μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλες, απροβλέπτες επιπτώσεις σε γενικότερο επίπεδο (Lorenz, 1963). Για παράδειγμα ένα φαινομενικά ασήμαντο γεγονός όπως η αποψίλωση μιας μικρής περιοχής, μπορεί να αποτελέσει την αιτία μιας πλημμύρας, η οποία με τη σειρά της θα έχει άμεση επίδραση στους ανθρώπους της περιοχής αυτής, με σοβαρές καταστροφές περιουσιών και πιθανότητα ανθρώπινων απωλειών. Τέλος όλες αυτές οι αλυσιδωτές αντιδράσεις θα προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στη ψυχική υγεία των ανθρώπων, προκαλώντας τους ψυχικές διαταραχές (πχ κατάθλιψη και μετατραυματικό στρες).

Παρακάτω αναλύονται εννιά βασικές ψυχικές διαταραχές που μαστιίζουν στις μέρες μας. Η περιβαλλοντική κρίση αποτελεί έναν θεμελιακό παράγοντα στην εμφάνιση αυτών των διαταραχών.

2.1.2 ΟΞΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΡΕΣ (ACUTE STRESS DISORDER, ASD)

Είναι μια από τις ψυχικές διαταραχές που εμφανίζεται ως απάντηση του οργανισμού σε ένα πολύ ισχυρό ψυχοτραυματικό γεγονός. Η οξεία διαταραχή στρες είναι ένας πρόδρομος της διαταραχής μετατραυματικού στρες (Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD). (ΠΕΤΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, 2017 και Bryant, R. 2017)

Η ASD εμφανίζεται τις πρώτες 2 ήμερες έως 4 εβδομάδες από το τραυματικό γεγονός και αν τα συμπτώματα επιμένουν μετά το πέρας των 4 εβδομάδων, εξελίσσεται σε PTSD (Bryant, R. et al., 2017).

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα που αναφέρονται είναι: τρόμος, φόβος, απόγνωση, αίσθημα εγκατάλειψης, δυσχέρια συγκέντρωσης, διαταραχή μνήμης, φόβο επικείμενου θανάτου, άγχος, αϋπνία, απόσυρση, αποφυγή ερεθισμάτων που συνδέονται με την αναβίωση του γεγονότος (ΠΕΤΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, 2017). Σύμφωνα με τον Bryant τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Επαναβίωση του τραύματος: Επίμονες και ακούσιες επαναβιώσεις του τραύματος μέσω εφιαλτών ή φλασμπάκ.

Αποσύνδεση: Συναισθήματα απομάκρυνσης από την πραγματικότητα ή το περιβάλλον (συνεσθηματικό μούδιασμα).

Αποφυγή: Προσπάθεια αποφυγής σκέψεων ή καταστάσεων που σχετίζονται με το τραύμα.

Υπερδιέγερση: Αυξημένα επίπεδα άγχους, ευερεθιστότητας και δυσκολίας συγκέντρωσης ή ύπνου. (Bryant, 2016).

Τα διαγνωστικά κριτήρια για την οξεία διαταραχή όπως ορίζονται στο DSM-5. Περιλαμβάνουν 9 από τα 14 συμπτώματα που χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες: επανεμφάνιση, αρνητική διάθεση, αποσύνδεση, αποφυγή και υπερδιέγερση (American Psychiatric Association, 2013).

Η αντιμετώπιση και η θεραπεία της ASD επικεντρώνεται στην πρόληψη της ανάπτυξης PTSD. Περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο ψυχολογικές παρεμβάσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις φαρμακευτική αγωγή. Η θεραπεία που εφαρμόζεται είναι γνωστή στο τομέα της ψυχολογίας ως γνωστική συμπεριφορική θεραπεία (CBT) (Roberts, 2019). Η φαρμακευτική αγωγή που

χρησιμοποιείται σε ορισμένες περιπτώσεις, περιλαμβάνει αντικαταθλιπτικά και αγχολυτικά, για τη μείωση των συμπτωμάτων άγχους και υπερδιέγερσης. Ωστόσο η φαρμακευτική αγωγή συνδιάζεται με ψυχολογική θεραπεία για καλύτερα αποτελέσματα (Kearns, 2012).

2.1.3 ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ (POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER, PTSD)

Η διαταραχή μετατραυματικού στρες όπως προαναφέραμε αφορά την μετεξέλιξη της οξείας διαταραχής στρες ASD και χαρακτηρίζεται ως ψυχιατρική διαταραχή. Εμφανίζεται όταν το άτομο έχει εκτεθεί σε τραυματικές εμπειρίες και γεγονότα που απείλησαν τη ζωή του όπως: φυσικές καταστροφές, σοβαρά ατυχήματα, σεξουαλική κακοποίηση ή καταστάσεις πολέμων.

Τα χαρακτηριστικά του μετατραυματικού στρες που οδηγούν κάποιον ειδικό στη διάγνωση σύμφωνα με το DSM-5 είναι: Επανεμπειρίες του τραύματος (πχ αναδρομές και εφιάλτες), αποφυγή ερεθισμάτων που σχετίζονται με το τραύμα, αρνητικές μεταβολές στη διάθεση και τη σκέψη (πχ συνεσθηματικό μούδιασμα, επίμονα αρνητικά συναισθήματα) και αυξημένη διέγερση (πχ ευερεθιστότητα, προβλήματα ύπνου, υπερ-επαγρύπνηση). (Diagnostic and Statistical Manual Disorders, 5^η έκδοση)

Συνεπώς τα συμπτώματα του PTSD χωρίζονται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες:

- Επαναβίωση του τραύματος.
- Αποφυγή.
- Αρνητικές αλλαγές στη σκέψη και τη διάθεση.
- Αυξημένη αντιδραστικότητα. (American Psychiatric Association, 2013).

Αντιμετώπιση και Θεραπεία

Η θεραπεία της PTSD περιλαμβάνει ψυχολογικές και φαρμακευτικές προσεγγίσεις:

Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT): Η CBT είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους αντιμετώπισης της PTSD και περιλαμβάνει την έκθεση στο τραύμα με ελεγχόμενο τρόπο (Cahill et al., 2014). Ειδικές μορφές CBT, όπως η θεραπεία μέσω επανεπεξεργασίας και απευαισθητοποίησης με κινήσεις των ματιών (EMDR), έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές (Shapiro, 2014).

Φαρμακευτική Αγωγή: Τα αντικαταθλιπτικά, ιδιαίτερα τα SSRIs (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors), όπως η σερτραλίνη και η παροξετίνη, είναι εγκεκριμένα για τη θεραπεία της PTSD (Hoskins et al., 2015). Σε ορισμένες περιπτώσεις, χορηγούνται και αγχολυτικά ή α-αδρενεργικοί αναστολείς για τη μείωση της υπερδιέγερσης και των εφιαλτών.

Ομαδική θεραπεία: Η θεραπεία σε ομάδα μπορεί να προσφέρει επιπλέον υποστήριξη και ευκαιρίες για διαμοιρασμό εμπειριών, ιδιαίτερα σε στρατιωτικούς βετεράνους ή θύματα βίας (Sloan et al., 2013).

2.1.4 ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (ADJUSTMENT DISORDER).

Η διαταραχή προσαρμογής, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στην ψυχιατρική και τη ψυχολογία. Για να περιγράψει μια βραχείας διάρκειας, δυσπροσαρμοστική αντίδραση. Ενός ατόμου σε νέες καταστάσεις ή περιβάλλοντα. Συνήθως αναφέρεται στην αδυναμία προσαρμογής σε κανονικές καθημερινές απαιτήσεις ή σε κρίσιμες καταστάσεις, όπως αλλαγές στην εργασία, στις σχέσεις ή σε προσωπικές κρίσεις κάτι που του δημιουργεί ψυχοκοινωνικό στρες.

Ωστόσο οι διαταραχές προσαρμογής παρουσιάζουν διαγνωστικά διλήμματα στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Καθώς δεν υπάρχει επαρκής ορισμός βιβλιογραφικά. Με αποτέλεσμα να επικαλύπτονται από άλλες διαγνωστικές ομάδες. Στο DSM-5 γίνεται αναφορά στη διαταραχή προσαρμογής ως μιας μη ανεξάρτητης διαταραχής. Αλλά ως μιας διαταραχής που είναι παρακλάδι άλλων διαταραχών οι οποίες προκαλούνται από τραυματικά γεγονότα (πχ PTSD).

Τα συμπτώματα στα θύματα των φυσικών καταστροφών που πάσχουν από τη διαταραχή προσαρμογής είναι: Κατάθλιψη, άγχος, δραματική συμπεριφορά, βίαια ξεσπάσματα, διαταραχές συμπεριφοράς (επιθετική ή αντικοινωνική συμπεριφορά), αδυναμία συγκέντρωσης, ταχυκαρδία, δύσπνοια και μυϊκός τρόμος. (ΠΕΤΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, 2017) (APA Dictionary of Psychology, 2023).

2.1.5 SOLASTALGIA

Η solastalgia είναι ένας νέος όρος που περιγράφει τη ψυχική και συναισθηματική δυσφορία, που προκαλείται στους ανθρώπους όταν το φυσικό τους περιβάλλον, υφίσταται αρνητικές αλλαγές. Σε αντίθεση με τη νοσταλγία, η οποία αναφέρεται στην επιθυμία (πχ για ένα σπίτι που έχει εγκαταλειφθεί). Η solastalgia αναφέρεται στη συναισθηματική δυσφορία και αγωνία

του ατόμου που εξακολουθεί και ζει στον ίδιο τόπο ο οποίος έχει υποστεί αλλαγές (πχ φυσικές καταστροφές), κάνοντας το να νοσταλγεί την αίσθηση ασφάλειας και παρηγοριάς, που του πρόσφερε το προηγούμενο περιβάλλον. (Albrecht G. 2005 & Warsini, S., Mills, J., & Usher, K. 2014).

Ο όρος επινοήθηκε από τον Αυστραλό φιλόσοφο Glenn Albrecht στις αρχές του 21^{ου} αιώνα και αποτελείται από τη λέξη “solace” (παρηγοριά) και “algia” (πόνος). Αυτή η συναισθηματική κατάσταση μπορεί να συνδεθεί άμεσα με τη κλιματική αλλαγή, τις φυσικές καταστροφές τη ρύπανση και τη περιβαλλοντική υποβάθμιση. Οι άνθρωποι που βιώνουν solastalgia μπορεί να παρουσιάσουν συμπτώματα όπως: άγχος, κατάθλιψη και αίσθηση αβοηθησίας. (Albrecht G. 2005 & Warsini, S., Mills, J., & Usher, K. 2014 & Sarah Vanbuskirk, 2023).

2.1.6 ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΓΧΩΔΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (GENERALIZED ANXIETY DISORDER, GAD).

Είναι μια από τις πιο κοινές ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως και χαρακτηρίζεται από υπερβολικό άγχος και ανησυχία, που είναι δύσκολο να ελεγχθούν και συχνά δεν συνδέονται με συγκεκριμένα γεγονότα ή καταστάσεις. Το άτομο βιώνει συνεχή ένταση και ανησυχία για μια πληθώρα θεμάτων. (Beesdo, K., et al. 2009 & Stein, M. B., & Sareen, 2015).

Σύμφωνα με το DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual Disorders, 5^η έκδοση). Η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή πρέπει να πληροί τα εξής κριτήρια:

- Υπερβολική ανησυχία και άγχος που εκφράζεται τις περισσότερες μέρες σε διάστημα 6 μηνών.
- Δυσκολία διαχείρισης και ελέγχου του άγχους
- Συνδέεται με τουλάχιστος τρία από τα εξής συμπτώματα (Ανησυχία, Κόπωση, Δυσκολία συγκέντρωσης, Ευρεθιστότητα, Μυϊκή ένταση, Διαταραχές ύπνου).
- Το άγχος προκαλεί στο άτομο σημαντική δυσφορία ή διαταραχή στις κοινωνικές, επαγγελματικές ή άλλες σημαντικές δραστηριότητες.
- Δεν οφείλεται σε άλλη ψυχική διαταραχή, φαρμακευτική αγωγή ή χρήση ουσιών. (DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. American Psychiatric Association, 2013).

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η αιτία της GAD δεν είναι πλήρως κατανοητή, αλλά πιθανολογείται ότι προέρχεται από συνδυασμό γενετικών, περιβαλλοντικών και βιολογικών

παραγόντων. Η δυσλειτουργία σε συγκεκριμένα νευροχημικά συστήματα, όπως ο γ-αμινοβουτυρικός οξύς (GABA), παίζει ρόλο. Επίσης, το χρόνιο άγχος μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο διαχειρίζεται τις αγχωτικές καταστάσεις. (Beesdo, K., et al., 2009 & Stein, M. B., & Sareen, J., 2015 & Harvard Health, 2014).

Τα κύρια συμπτώματα περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο: υπερβολικό άγχος για καθημερινές δραστηριότητες, δυσκολία στη χαλάρωση (συνεχές αίσθημα έντασης), σωματικά συμπτώματα, διαρκές αίσθημα απειλής. (Harvard Health, 2014).

Η θεραπεία της GAD συνδιάζει ψυχολογικές παρεμβάσεις και φαρμακευτική αγωγή. Σε ψυχολογικό επίπεδο εφαρμόζεται η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία η οποία εστιάζει στην αλλαγή των αρνητικών σκέψεων και συμπεριφορών που τροφοδοτούν το άγχος. Όσον αφορά τη φαρμακευτική αγωγή Τα πιο αποτελεσματικά φάρμακα για βραχυπρόθεσμη θεραπεία είναι οι βενζοδιαζεπίνες, οι οποίες καταπραΰνουν τα συμπτώματα του άγχους σε περίπου τους μισούς ανθρώπους, που πάσχουν από γενικευμένη αγχώδη διαταραχή. Για μακροχρόνια θεραπεία, μπορεί να συνταγογραφηθούν αντικαταθλιπτικά και το αγχολυτικό φάρμακο βουσπιρόνη για την πρόληψη της επανεμφάνισης του άγχους. (Harvard Health, 2014).

2.1.7 ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Η κατάθλιψη, δεν εμφανίζεται σε όλους τους ασθενείς με τα ίδια συμπτώματα. Άλλοι είναι θλιμμένοι, απελπισμένοι, απογοητευμένοι, άλλοι μεμψιμοιρούν και γκρινιάζουν συνεχώς, άλλοι παραπονιούνται για πλήθος σωματικών ενοχλημάτων. (ΠΕΤΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, 2017).

Οι καταθλιπτικές διαταραχές είναι μια ομάδα ψυχικών διαταραχών που χαρακτηρίζονται κυρίως από την παρουσία έντονης και παρατεταμένης θλίψης, αλλαγή διάθεσης, αίσθημα κενού και απελπισίας. Αύτα τα συμπτώματα είναι κοινά γνωρίσματα όλων των διαταραχών κατάθλιψης, επιρεάζοντας αρνητικά την καθημερινή λειτουργικότητα του ατόμου. Η πιο γνωστή μορφή καταθλιπτικής διαταραχής είναι η μείζονα καταθλιπτική διαταραχή (Major Depressive Disorder - MDD), αλλά υπάρχουν και άλλες μορφές, όπως: επίμονη καταθλιπτική διαταραχή (δυσθυμία), οι καταθλιπτικές διαταραχές λόγω ιατρικών παθήσεων ή ψυχοκοινωνικών παραγόντων. (World Health Organization. 2021 & American Psychiatric Association, DSM-5, 2013).

i. Μείζονα καταθλιπτική διαταραχή (Major Depressive Disorder - MDD)

Η μείζονα καταθλιπτική διαταραχή είναι μια από τις σοβαρότερες και συχνά διαγνωσμένες καταθλιπτικές διαταραχές. Είναι γνωστή και ως κλινική κατάθλιψη. Σύμφωνα με το DSM-5, για να γίνει η διάγνωση πρέπει το άτομο να εμφανίζει τουλάχιστον πέντε από τα ακόλουθα συμπτώματα, για διάστημα τουλάχιστον δυο εβδομάδων. Με ένα από αυτά να είναι η καταθλιπτική διάθεση ή η έλλειψη ενδιαφέροντος/ευχαρίστησης για τις περισσότερες από τις δραστηριότητες που το άτομο παλιότερα συνήθιζε να κάνει. (American Psychiatric Association, 2013)

Τα συμπτώματα είναι τα εξής: καταθλιπτική διάθεση για μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, έντονη μείωση του ενδιαφέροντος για δραστηριότητες, σημαντική απώλεια ή αύξηση βάρους (χωρίς δίαιτα), αϋπνία ή υπερυπνία, ψυχοκινητική διέγερση ή επιβράδυνση, κόπωση ή έλλειψη ενέργειας, αίσθημα αναξιότητας ή υπερβολικής ενοχής, μειωμένη ικανότητα σκέψης ή συγκέντρωσης και επαναλαμβανόμενες σκέψεις θανάτου ή αυτοκτονίας. (American Psychiatric Association, 2013)

Η MDD μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κοινωνική, επαγγελματική και προσωπική λειτουργικότητα των ατόμων που πάσχουν. Επίσης, είναι η κύρια αιτία αναπηρίας παγκοσμίως, επηρεάζοντας κυρίως τον ενήλικο πληθυσμό, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε εφήβους και παιδιά (Ferrari et al., 2013).

ii. Επίμονη καταθλιπτική διαταραχή (Δυσθυμία).

Η επίμονη καταθλιπτική διαταραχή ή αλλιώς δυσθυμία χαρακτηρίζεται από χρόνια καταθλιπτικά συμπτώματα που διαρκούν για τουλάχιστον 2 χρόνια σε ενήλικες ή 1 χρόνο σε παιδιά και εφήβους (Klein & Santiago, 2016). Τα συμπτώματα της δυσθυμίας σε αντίθεση με την MDD είναι πιο ήπια, αλλά διαρκούν περισσότερο.

Τα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνουν: Χαμηλή διάθεση για μεγάλο μέρος της ημέρας, απώλεια ενδιαφέροντος ή απόλαυσης για δραστηριότητες, χαμηλή αυτοεκτίμηση, αίσθημα ελπίδας ή αναξιότητας, κόπωση και χαμηλή ενέργεια. (American Psychiatric Association, 2013).

iii. Άλλες Μορφές Καταθλιπτικών Διαταραχών

Ψυχωτική κατάθλιψη: Σε αυτή τη μορφή, η κατάθλιψη συνοδεύεται από ψυχωτικά συμπτώματα όπως παραληρητικές ιδέες ή ψευδαισθήσεις, συνήθως με θέματα ενοχής ή

αναξιοτήτας. Η ψυχωτική κατάθλιψη απαιτεί πιο εντατική θεραπεία, συνήθως συνδυασμό αντικαταθλιπτικών και αντιψυχωσικών φαρμάκων (Gaudiano et al., 2005).

Εποχιακή συναισθηματική διαταραχή (Seasonal Affective Disorder - SAD): Πρόκειται για μια μορφή κατάθλιψης που σχετίζεται με τις εποχιακές αλλαγές, πιο συχνά κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν το φυσικό φως είναι περιορισμένο. Η θεραπεία με φωτοθεραπεία (light therapy) είναι αποτελεσματική για την αντιμετώπιση αυτής της διαταραχής (Rosenthal et al., 1984).

Καταθλιπτική διαταραχή προσαρμογής: Αυτή η μορφή κατάθλιψης αναπτύσσεται ως αντίδραση σε συγκεκριμένα στρεσογόνα γεγονότα, όπως ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου, το διαζύγιο, ή μια επαγγελματική απώλεια. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι λιγότερο έντονα από τη MDD, αλλά επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του ατόμου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (Zisook & Shear, 2009).

Οι καταθλιπτικές διαταραχές προκύπτουν από την αλληλεπίδραση πολλών βιολογικών, ψυχολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων:

Γενετική προδιάθεση: Βασικό ρόλο σύμφωνα με τη βιβλιογραφία φαίνεται να κατέχει η κληρονομικότητα στην εμφάνιση διαταραχών κατάθλιψης. Με τις έρευνες να δείχνουν ότι, άτομα με οικογενειακό ιστορικό κατάθλιψης, έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καταθλιπτικών διαταραχών (Sullivan et al., 2000).

Βιολογικοί παράγοντες: Οι ανισορροπίες σε νευροδιαβιβαστές όπως η σεροτονίνη, η ντοπαμίνη και η νοραδρεναλίνη σχετίζονται με την εμφάνιση καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Η νευροεπιστημονική έρευνα δείχνει επίσης ότι δομικές αλλαγές σε περιοχές του εγκεφάλου όπως ο προμετωπιαίος φλοιός και ο ιππόκαμπος μπορεί να σχετίζονται με την κατάθλιψη (Nestler et al., 2002)

Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες: Τραυματικές εμπειρίες ζωής, όπως η παιδική κακοποίηση ή η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, το χρόνιο στρες, οι δυσκολίες στην οικογένεια ή στις σχέσεις, καθώς και τα κοινωνικά προβλήματα (π.χ. φτώχεια, ανεργία), είναι ισχυροί προγνωστικοί παράγοντες για την εμφάνιση καταθλιπτικών διαταραχών (Kendler et al., 2006).

Η θεραπεία των καταθλιπτικών διαταραχών περιλαμβάνει μια συνδυαστική προσέγγιση φαρμακευτικής αγωγής και ψυχοθεραπείας. Σημαντικές μέθοδοι θεραπείας περιλαμβάνουν:

Φαρμακευτική αγωγή: Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, όπως οι αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs) και νοραδρεναλίνης (SNRIs), είναι συχνά αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης (Gelenberg et al., 2010). Η επιλογή του φαρμάκου εξαρτάται από τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και την ανταπόκριση του ασθενούς στη θεραπεία.

Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία (Cognitive Behavioral Therapy - CBT): Η CBT είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές ψυχοθεραπείες για την κατάθλιψη, επικεντρώνοντας στην αναγνώριση και τροποποίηση των αρνητικών σκέψεων και των δυσλειτουργικών μοτίβων συμπεριφοράς που σχετίζονται με την κατάθλιψη (Cuijpers et al., 2021).

Διαπροσωπική Θεραπεία (Interpersonal Therapy - IPT): Η IPT επικεντρώνεται στις διαπροσωπικές σχέσεις και στη βελτίωση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, στοχεύοντας να βοηθήσει τα άτομα να βελτιώσουν τη λειτουργικότητά τους στις καθημερινές τους σχέσεις (Markowitz & Weissman, 2012).

Άλλες μέθοδοι θεραπείας: Για τα άτομα που δεν ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή ή την ψυχοθεραπεία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες θεραπείες, όπως η ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT), η διακρανιακή μαγνητική διέγερση (TMS) ή η βαθιά εγκεφαλική διέγερση (DBS), με καλά αποτελέσματα σε πιο ανθεκτικές περιπτώσεις κατάθλιψης (Lisanby, 2007).

Οι καταθλιπτικές διαταραχές είναι πολυδιάστατες και περιλαμβάνουν μια ποικιλία μορφών και εκδηλώσεων, από την μέτρια καταθλιπτική διαταραχή έως τις πιο εξειδικευμένες μορφές όπως η ψυχωτική κατάθλιψη και η δυσθυμία. Οι αιτίες τους είναι περίπλοκες, με γενετικούς, βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες να παίζουν σημαντικό ρόλο. Η θεραπεία είναι συνήθως αποτελεσματική όταν είναι εξατομικευμένη και συνδυάζει φαρμακευτική αγωγή και ψυχοθεραπεία. Ωστόσο, η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και βελτίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας παραμένει επιτακτική.

2.1.8 ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΑΝΙΚΟΥ (PANIC DISORDER).

Η διαταραχή πανικού είναι μια αγχώδης διαταραχή. Η οποία διακρίνεται από κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως : επαναλαμβανόμενες, απρόβλεπτες κρίσεις πανικού και ξαφνικά επεισόδια έντονου άγχους και φόβου. Τα οποία συνοδεύονται από σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα όπως : Δύσπνοια, ταχυκαρδία, ζαλάδες, εφίδρωση καθώς και αίσθημα απώλειας ελέγχου ή επικείμενου θανάτου. Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί πως η διαταραχή πανικού διαφέρει από μια απλή κρίση πανικού τόσο σε διάρκεια όσο και στο γεγονός ότι η διαταραχή πανικού δημιουργεί στο άτομο μια διαρκή ανησυχία για την επανεμφάνιση μελλοντικών κρίσεων κάνοντας το έτσι να αποφεύγει διαρκώς καταστάσεις που μπορεί να του προκαλέσουν κρίσεις. (American Psychiatric Association, 2013).

Σύμφωνα με το DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition), για να γίνει διάγνωση κάποιου ατόμου με διαταραχή πανικού πρέπει να πληρούνται κάποια κριτήρια:

Επαναλαμβανόμενες και απροσδόκητες κρίσεις πανικού, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τέσσερα από τα παρακάτω συμπτώματα : Ταχυκαρδία ή έντονοι καρδιακοί παλμοί, ιδρώτας, τρόμος ή τρέμουλα, δύσπνοια ή αίσθημα πνιγμού, πόνος στο στήθος, ναυτία ή στομαχικές ενοχλήσεις, ζαλάδα ή λιποθυμικές τάσεις, αποπροσωποποίηση (αίσθημα αποσύνδεσης από το σώμα) ή αποπραγματοποίηση (αίσθημα ότι τα γεγονότα δεν είναι πραγματικά, Φόβος θανάτου, μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα και κρυάδες ή εξάψεις.

Συνεχής ανησυχία για την πιθανότητα νέων κρίσεων ή τις συνέπειες αυτών των κρίσεων για τουλάχιστον ένα μήνα.

Αλλαγή στη συμπεριφορά του ατόμου κατά την οποία παρατηρούνται ξαφνικές αλλαγές στη διάθεση του ατόμου χωρίς να είναι ορατή η αιτία. (American Psychiatric Association, 2013).

Η διαταραχή πανικού φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα μιας σύνθετης αλληλεπίδρασης βιολογικών, ψυχολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων:

Βιολογικοί παράγοντες: Γενετική προδιάθεση: υπάρχουν ενδείξεις ότι η διαταραχή πανικού μπορεί να έχει γενετική βάση καθώς παρατηρείται συχνότερη εμφάνισή της σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό αγχώδων διαταραχών. Νευροχημικές ανισσοροπίες: ορμόνες όπως σεροτονίνη και η νορεπινεφρίνη καθώς και τα επίπεδα του γ-αμινοβουτυρικού οξέος (GABA),

παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του άγχους. Συνεπώς η απορρύθμιση σε αυτά τα συστήματα μπορεί να συνδεθεί με την εμφάνιση της διαταραχής. Τέλος σημαντικό ρόλο κατέχουν η υπερευαισθησία του αυτόνομου νευρικού συστήματος, η υπερδραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού συστήματος μπορεί να προκαλέσει σωματικά συμπτώματα. (Craske, M. G., & Barlow, D. H., 2007).

Ψυχολογικοί παράγοντες: Γνωσιακές στρεβλώσεις: Άτομα με διαταραχή πανικού συχνά παρερμηνεύουν τα σωματικά τους συμπτώματα ως ένδειξη επικείμενου κινδύνου, όπως η απώλεια ελέγχου ή θάνατος, γεγονός που ενισχύει το φόβο τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κρίσεις πανικού μπορεί να εμφανιστούν ως αντίδραση σε προηγούμενα τραυματικά ή αγχώδη γεγονότα, με αποτέλεσμα το άτομο να αναπτύσσει φόβο για συγκεκριμένες καταστάσεις. (Roy-Byrne, P. P., Craske, M. G., & Stein, M. B., 2006).

Περιβαλλοντικοί παράγοντες: Στρεσογόνα γεγονότα ζωής: Οι αλλαγές σε διάφορους τομείς της ζωής ή η απώλεια αγαπημένου προσώπου καθώς και άλλες καταστάσεις που δημιουργούν έντονο στρες (πχ περιβαλλοντικές καταστροφές, απώλεια περιουσιών). Μπορούν να προκαλέσουν την έναρξη της διαταραχής. Τέλος το οικογενιακό περιβάλλον φαίνεται να κατέχει σημαντικό ρόλο στην έναρξη της διαταραχής. Καθώς υπάρχουν ενδείξεις πως άτομα που μεγάλωσαν σε περιβάλλοντα με υπερβολικό άγχος ή υπερπροστατευτικούς γονείς είναι πιο επιρρεπή στην ανάπτυξη αγχώδων διαταραχών. (Goodwin, R. D., & Hamilton, S. P., 2002).

Η θεραπεία της διαταραχής πανικού συνήθως περιλαμβάνει ψυχοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή ή συνδυασμό αυτών. Όπως και στις προαναφερθείσες διαταραχές έτσι και στη συγκεκριμένη. Πολύ βασικό εργαλείο στην αντιμετώπιση κατέχει η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία (CBT) η οποία πολλές φορές σε συνδυασμό με τη κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που πάσχουν από μια διαταραχή να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή χωρίς φόβο. Τέλος η εκπαίδευση τόσο του ατόμου όσο και του περιβάλλοντος του σχετικά με τη διαταραχή, τη κατανόηση των συμπτωμάτων και τη διαχείριση των κρίσεων. Μπορεί να επιταχύνει τη θεραπεία. (Roy-Byrne, P. P., Craske, M. G., & Stein, M. B., 2006 & Craske, M. G., & Barlow, D. H., 2007).

2.1.9 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΠΝΟΥ.

Ο όρος διαταραχές ύπνου χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει ένα ευρύ φάσμα δυσλειτουργιών που επηρεάζουν τη ποσότητα τη ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου. Κάτι που φέρει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της καθημερινής λειτουργικότητας και της υγείας ενός ατόμου. Σύμφωνα με το International Classification of Sleep Disorders (ICSD), οι διαταραχές ύπνου κατατάσσονται σε κάποιες κατηγορίες. Οι οποίες αφορούν: την αϋπνία, τις διαταραχές του κικκάδιου ρυθμού, την υπερυπνία, τις παραϋπνίες και τις διαταραχές της αναπνοής κατά τον ύπνο. (American Academy of Sleep Medicine, 2014).

Αϋπνία: Ως αϋπνία χαρακτηρίζεται η κατάσταση κατά την οποία ένα άτομο δυσκολεύεται στην έναρξη ή τη διατήρηση του ύπνου. Σύχνα συμπτώματα τα οποία φαίνεται πως συνοδεύουν την αϋπνία είναι: η κόπωση, η δυσκολία συγκέντρωσης και η ευερεθιστότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επιπρόσθετα η αϋπνία μπορεί να εμφανιστεί είτε ως παροδικό φαινόμενο (λόγω ψυχολογικού στρες ή περιβαλλοντικών παραγόντων), είτε ως χρόνια κατάσταση που συσχετίζεται με σωματικές και ψυχικές ασθένειες. Τέλος έχει γίνει φανερό από κλινικές μελέτες ότι η αϋπνία συνδέεται συχνά με διαταραχές διάθεσης (πχ κατάθλιψη και άγχος). (Riemann, Spiegelhalder, et al., 2010).

Διαταραχές του κικκάδιου ρυθμού: Οι διαταραχές αυτές έχουν άμεση σχέση με τυχόν διαταραχές του εσωτερικού ρυθμού του σώματος, κατά τις οποίες επηρεάζεται το πρόγραμμα ύπνου και της εγρήγορσης. Ο βασικότερος παράγοντας που προκαλεί αυτές τις διαταραχές είναι το περιβάλλον του ατόμου και ο τρόπος ζωής του. Καθώς οι πιο συνηθείς μορφές τους είναι το σύνδρομο καθυστερημένης φάσης ύπνου, η αδυναμία συγχρονισμού με τον φυσικό κύκλο ημέρας και νύχτας, και η απορρύθμιση που συνδέεται με επαγγελματικά ταξίδια (jet lag) ή βάρδιες εργασίας. Στον εγκέφαλο ο ρυθμός αυτός ελέγχεται από τον υπερχιασματικό πυρήνα, ο οποίος συγχρονίζεται με το φως και το σκοτάδι του περιβάλλοντος (Zee, 2010).

Υπνική άπνοια: Εμφανίζεται ως μια από τις πιο σύχνες διαταραχές αναπνοής κατά τον ύπνο. Διακρίνεται σε αποφρακτική και κεντρική μορφή. Στην αποφρακτική υπνική άπνοια η διακοπή της αναπνοής προκαλείται από την απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών, με αποτέλεσμα τη μη επαρκή οξυγόνωση του αίματος. Όσον αφορά τη κεντρική άπνοια σχετίζεται με τη διαταραχή της λειτουργίας του εγκεφαλικού στελέχους που ελέγχει την αναπνοή. Αυξάνοντας έτσι το κίνδυνο για καρδιαγγειακές παθήσεις. (Punijabi, 2008).

Παραϋπνίες: Αφορούν ανεπιθύμητες συμπεριφορές ή φαινόμενα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του ύπνου, όπως υπνοβασία, εφιάλτες και νυχτερινοί τρόμοι. Οι αιτίες τους συνδέονται με νευρολογικές ανωμαλίες που εμποδίζουν την κανονική διαδοχή των σταδίων του ύπνου REM και NREM (Mahowald & Schenck, 2005).

Οι διαταραχές ύπνου αφορούν ένα περίπλοκο και πολυπαραγοντικό ζήτημα, με σημαντικές επιπτώσεις τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Για να επιτευχθεί μια ακριβής διάγνωση είναι απαραίτητη η συνεργασία διάφορων ιατρικών ειδικοτήτων καθώς και η χρήση πολυδιάστατων μεθόδων διάγνωσης (πχ πολυπνογραφία).

Η έρευνα συνεχίζει να αποκαλύπτει σημαντικές συνδέσεις μεταξύ ύπνου και ασθενειών, προσφέροντας νέες προοπτικές για θεραπευτικές προσεγγίσεις και βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής των ατόμων με διαταραχές ύπνου (Kryger, Roth & Dement, 2017).

2.1.10 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Οι διαταραχές διατροφής κατηγοριοποιούνται στη βιβλιογραφία ως ψυχιατρικές διαταραχές, με σημαντικές σωματικές, συναισθηματικές και κοινωνικές συνέπειες. Οι κύριες κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι διαταραχές διατροφής είναι: Η νευρική ανορεξία, η νευρική βουλιμία και η διαταραχή υπερφαγίας. Οι διαταραχές αυτές επιδεινώνονται από το περιβάλλον και τις διαστρεβλωμένες αντιλήψεις που επικρατούν, όσον αφορά το σωματικό βάρος, κάτι το οποίο προσθέτει ένα ακόμα βάρος στα άτομα τα οποία πάσχουν από κάποια διατροφική διαταραχή. (APA, 2013).

Νευρική ανορεξία: Κύριο χαρακτηριστικό της είναι ο έντονος φόβος της αύξησης του σωματικού βάρους και χαρακτηρίζεται από έντονη δίαιτα και σκόπιμη απώλεια βάρους. Έχει παρατηρηθεί πως τα άτομα που πάσχουν από νευρική ανορεξία έχουν μια διατρεβλωμένη εικόνα για το σώμα τους αντιμετωπίζοντας έτσι την σοβαρότητα της κατάστασης στην οποία βρίσκονται με άρνηση. Τα κριτήρια διάγνωσης που αναφέρονται στο DSM-5 είναι: Η σκόπιμη απώλεια βάρους, ο έντονος φόβος απόκτησης βάρους και η διαστρεβλωμένη εικόνα του σώματος (APA, 2013).

Νευρική βουλιμία: Η διαταραχή βουλιμίας χαρακτηρίζεται από επεισόδια υπερφαγίας κατά τα οποία το άτομο καταναλώνει μεγάλες ποσότητες τροφής σε σύντομο χρονικό διάστημα, ακολουθούμενα από αντισταθμιστικές συμπεριφορές (πχ πρόκληση εμετού) (APA, 2013). Αυτές οι αντισταθμιστικές ενέργειες γίνονται από το άτομο προκειμένου να ελεγχθεί το σωματικό

του βάρους και η σοβαρότητα της κατάστασης κρίνεται από τη συχνότητα και την ένταση των συμπτωμάτων. (Fairburn & Harrison, 2003).

Διαταραχή υπερφαγίας: Αποτελεί τη συχνότερη διαταραχή διατροφής και σύμφωνα με το DSM-5 χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια ανεξέλεγκτης κατανάλωσης τροφής χωρίς επακόλουθες αντισταθμιστικές συμπεριφορές. (APA, 2013). Το άτομο συχνά μετά από το ξέσπασμα κάποιου επεισοδίου, διακατέχεται από συναισθήματα ντροπής και ενοχής. Τέλος αυτή η διαταραχή συχνά συνοδεύεται με παχισαρκία και σοβαρές ψυχοσωματικές συνέπειες. (Hudson et al., 2007).

Η αιτιολογία των διαταραχών διατροφής είναι πολύπλοκη και πολυπαραγοντική. Περιλαμβάνει γενετικούς, βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικοπολιτισμικούς παράγοντες. Μελέτες σε δίδυμα και οικογενειακά δείγματα έχουν υποδείξει την ύπαρξη γενετικών παραγόντων που συμβάλλουν στον κίνδυνο ανάπτυξης αυτών των διαταραχών, ιδιαίτερα στη νευρική ανορεξία και τη νευρική βουλιμία (Kaye et al., 2000). Επιπλέον, οι κοινωνικές πιέσεις για αδύνατο σώμα, κυρίως στις δυτικές κοινωνίες, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση των διαταραχών διατροφής, ειδικά στις νεαρές γυναίκες (Striegel-Moore & Bulik, 2007).

Η θεραπεία των διαταραχών διατροφής απαιτεί πολυδιάστατη προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει ψυχοθεραπεία, διατροφική καθοδήγηση και ιατρική παρακολούθηση. Έχει αποδειχθεί πως οι γνωσιακές-συμπεριφορικές θεραπείες είναι αποτελεσματικότερες στη βελτίωση των συμπτωμάτων (Fairburn et al., 2003). Η φαρμακευτική αγωγή μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των συνοδών ψυχιατρικών καταστάσεων, όπως η κατάθλιψη και το άγχος (Hay et al., 2014).

2.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΑΣΤΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ.

Όλες οι παραπάνω διαταραχές προκαλούνται από διάφορους παράγοντες και συνήθως από τον συνδυασμό περισσότερων από δύο παραγόντων (πχ από περιβαλλοντικούς, ψυχολογικούς, συναισθηματικούς, κοινωνικούς, σωματικούς, βιολογικούς). Όλοι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν καθημερινά τους ανθρώπους πέραν από τις διαταραχές που προκαλούν, είναι υπεύθυνοι και για δύο κοινωνικά φαινόμενα, τα οποία μαστίζουν στις σύγχρονες κοινωνίες. Τα φαινόμενα αυτά είναι: Ο αλκοολισμός - κατάχρηση ουσιών και ο αυτοκτονικός ιδεασμός - αυτοκαταστροφικές Συμπεριφορές.

2.2.1 Ο ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ

Αποτελούν φαινόμενα τα οποία χαρακτηρίζονται ως πολυπαραγοντικά καθώς προκύπτουν από το συνδυασμό διαφόρων παραγόντων όπως προαναφέρθηκε. Ωστόσο το περιβάλλον των ατόμων φαίνεται να κατέχει καθοριστικό ρόλο στην εκδήλωση ή μη αυτού του φαινομένου. Με τον όρο περιβάλλον στη συγκεκριμένη περίπτωση εννοούμε: Το οικογενειακό περιβάλλον, τις κοινωνικές σχέσεις και επιρροές, τις πολιτισμικές και κοινωνικοοικονομικές επιρροές, το εργασιακό περιβάλλον και το περιβάλλον κατοικίας.

- Οικογενειακό περιβάλλον: Αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς ενός ατόμου. Έρευνες έχουν δείξει ότι η ύπαρξη γονέων με ιστορικό εξάρτησης αυξάνει την πιθανότητα ανάπτυξης παρόμοιων συμπεριφορών στους απογόνους. (Velleman & Templeton, 2007).
- Κοινωνικές σχέσεις και επιρροές: Είναι σύνηθες φαινόμενο τα άτομα προκειμένου να γίνουν αποδεκτά να υιοθετούν συμπεριφορές και τάσεις. Συνεπώς πολύ νεοί ακολουθούν τις κακές συνήθειες των φίλων τους προκειμένου να αποφύγουν τυχόν αισθήματα αποκλεισμού και απομόνωσης. (Simons-Morton et al., 2016).
- Πολιτισμικές και κοινωνικοοικονομικές επιρροές: Οι άνθρωποι που ζουν σε περιβάλλοντα με χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτύξουν εξαρτήσεις, λόγω της υψηλότερης έκθεσης σε στρεσογόνους παράγοντες, όπως η ανεργία, η φτώχεια και η έλλειψη πρόσβασης σε εκπαιδευτικά και υγειονομικά συστήματα (Jarrold et al., 2021).
- Εργασιακό περιβάλλον: Οι υψηλές απαιτήσεις της δουλειάς, η υπερκόπωση, η έλλειψη ψυχολογικής υποστήριξης και οι δύσκολες σχέσεις με τους συναδέλφους μπορούν να

οδηγήσουν σε αυξημένο στρες κάνοντας το άτομο να αναζητήσει διέξοδο στις καταχρήσεις. (Frone, 2016).

- Περιβάλλον κατοικίας και γειτονιά: Τα άτομα που ζουν σε γειτονιές με αυξημένα ποσοστά εγκληματικότητας και βίας ή σε περιοχές όπου η κατάχρηση ουσιών είναι συχνή, έχουν περισσότερες πιθανότητες να υιοθετήσουν παρόμοιες συμπεριφορές. (Schulz et al., 2016).

2.2.2 Ο ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΔΕΑΣΜΟΣ - ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ.

Όπως ο αλκοολισμός και η κατάχρηση ουσιών, έτσι και ο αυτοκτονικός ιδεασμός αποτελεί πολυπαραγοντικά φαινόμενα. Τα οποία συχνά συνδέονται με ποικίλα κοινωνικά, ψυχολογικά και περιβαλλοντικά στοιχεία. Για να μπορέσει να αναλυθεί και να κατανοηθεί σε βάθος το φαινόμενο αυτό. Θα πρέπει να ελεγχθεί η αλληλεπίδραση που υπάρχει μεταξύ των ατομικών χαρακτηριστικών και του περιβάλλοντος του ατόμου. Οι βασικές διαστάσεις αυτής της σχέσεις είναι: Το κοινωνικό περιβάλλον, το οικογενειακό περιβάλλον, οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, οι πολιτισμικές και κοινωνικές νόρμες, το περιβάλλον εργασίας και η ψυχολογική ευαλωτότητα του ατόμου.

- Το κοινωνικό περιβάλλον αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στην εμφάνιση του αυτοκτονικού ιδεασμού. Καθώς οι άνθρωποι ως κοινωνικά όντα έχουν την ανάγκη για κοινωνική υποστήριξη και λειτουργικές κοινωνικές σχέσεις. Η έλλειψη αυτών των δύο οδηγεί στην ραγδαία αύξηση των αυτοκτονιών. Καθώς σύμφωνα με έρευνες τα άτομα που βιώνουν κοινωνική απομόνωση ή παρεκκλίνουν από τις κοινωνικές νόρμες είναι πιο επιρρεπή στην αυτοκτονία (Joiner et al., 2005).
- Το οικογενειακό περιβάλλον όπως και στον αλκοολισμό και τη κατάχρηση ουσιών, έτσι και στον αυτοκτονικό ιδεασμό είναι υπεύθυνο για τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς ενός ατόμου. Με αποτέλεσμα ένα μη υγιές οικογενειακό περιβάλλον να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών. Σύμφωνα με έρευνες παιδιά που μεγάλωσαν σε δυσλειτουργικές οικογένειες ή βίωσαν κακοποίηση στην παιδική ηλικία, έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν αυτοκτονικό ιδεασμό. (Evans et al., 2005).
- Η χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση και η οικονομική ανασφάλεια προκαλούν στα άτομα αυξημένο στρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των αυτοκτονιών σε χώρες οι οποίες βιώνουν οικονομική ύφεση και κοινωνικοπολιτική δυσχέρια. Έρευνες έδειξαν ότι η ανεργία, η οικονομική δυσπραγία και οι περιορισμένες εκπαιδευτικές ευκαιρίες

αυξάνουν τον κίνδυνο ψυχικών διαταραχών, όπως η κατάθλιψη, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την αυτοκτονία (Stack, 2000).

- Οι πολιτισμικές και κοινωνικές νόρμες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της αντίληψης για την αυτοκτονία και τις αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Ορισμένοι πολιτισμοί ή κοινωνικές ομάδες αντιμετωπίζουν την αυτοκτονία ως μέσο επίλυσης προσωπικών ή κοινωνικών προβλημάτων, ενώ άλλοι την στιγματίζουν έντονα (Durkheim, 1897).
- Το επαγγελματικό περιβάλλον όπως και στον αλκοολισμό έτσι και στους αυτοκτονικούς ιδεασμούς μπορεί να αποδειχτεί αιτία εμφάνισης αυτοκτονικών ιδεασμών. Καθώς οι υψηλές απαιτήσεις της δουλειάς, η υπερκόπωση, η έλλειψη ψυχολογικής υποστήριξης και οι δύσκολες σχέσεις με τους συναδέλφους. Οδηγούν το άτομο σε αίσθηση ματαιώτητας η οποία έχει ως επακόλουθο την αντιμετώπιση της αυτοκτονίας, ως μέσο διαφυγής από την όλη κατάσταση. (Blustein et al., 2013).
- Η ψυχολογική ευαλωτότητα σε συνδυασμό με αρνητικά περιβαλλοντικά ερεθίσματα, όπως η έκθεση σε τραυματικά γεγονότα, εντείνει τον αυτοκτονικό ιδεασμό. Άτομα που εκτίθενται σε τραυματικές εμπειρίες ή βρίσκονται σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου, όπως εμπόλεμες ζώνες ή φυλακές, εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών (Nock et al., 2008).

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.

Η παρούσα εργασία εστίασε στην πολυδιάστατη σύνδεση που προκύπτει ανάμεσα στο περιβάλλον και στη ψυχική υγεία, επιχειρώντας να αναδείξει τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών αλλαγών στον ψυχισμό και στη συναισθηματική ευεξία των ανθρώπων. Μέσα από τη διερεύνηση της βιβλιογραφίας κατέστη σαφές ότι το περιβάλλον ασκεί άμεση και έμμεση επιρροή στην ψυχική ευημερία, κάτι που το καθιστά έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στην εμφάνιση ψυχικών διαταραχών.

Πιο συγκεκριμένα μέσο της μελέτης ορισμένων παραμέτρων προκύπτει ότι η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, η καταστροφή των οικοσυστημάτων και η αυξανόμενη κλιματική αλλαγή δεν αποτελούν πλέον μόνο περιβαλλοντικά ζητήματα αλλά και ψυχιατρικές προκλήσεις. Μια βασική απόδειξη αποτελεί ο όρος της ψυχιατρικής “οικολογικό άγχος”. Αύτος ο όρος δημιουργήθηκε για να εξηγήσει το συνεχές άγχος, φόβο και αβεβαιότητα κάποιων ανθρώπων για το μέλλον του πλανήτη.

Επιτακτική είναι η ανάγκη για συνδιαστική συμβολή διαφόρων επιστημονικών πεδίων, όπως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η ιατρική, η περιβαλλοντική επιστήμη και η δημόσια υγεία. Με σκοπό την αντιμετώπιση τόσο των ψυχικών διαταραχών όσο και των περιβαλλοντικών αλλαγών. Καθώς το πρόβλημα ολοένα και επεκτείνεται προκαλώντας πολυδιάστατες συνέπειες.

Η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία του περιβάλλοντος για την ψυχική υγεία αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Όσο περισσότερα άτομα κατανοούν τη σύνδεση αυτή, τόσο πιο πιθανό είναι να αναλάβουν δράση για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα. Η κοινωνική αλληλεγγύη που δημιουργείται μέσα από την ευαισθητοποίηση αυτή ενισχύει όχι μόνο την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, αλλά και την ψυχολογική ευημερία των κοινοτήτων.

Επιπρόσθετα θετικό σύμμαχο στην αντιμετώπιση του προβλήματος της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, αποτελούν οι χώροι πρασίνου όπως πάρκα, κήποι και δάσος άμεσα προσβάσιμα στον κάθενα. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι η τακτική έκθεση στη φύση μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, βελτιώνει τη διάθεση και ενισχύει τη συνολική αίσθηση ευεξίας (Τζάκι Ντε Μπούρκα, 2024).

Η ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας αποτελεί ένα ακόμη βασικό συμπέρασμα της εργασίας. Σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών κρίσεων, όπως φυσικές καταστροφές ή

εκτεταμένη υποβάθμιση, οι ανάγκες για ψυχολογική υποστήριξη αυξάνονται δραματικά. Είναι ζωτικής σημασίας να αναπτυχθούν προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πληγέντων, περιλαμβάνοντας παροχή συμβουλευτικής, εκπαίδευση σε στρατηγικές ανθεκτικότητας και ομαδική υποστήριξη. Ταυτόχρονα, η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας σχετικά με την επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων στην ψυχική υγεία είναι απαραίτητη για τη σωστή διαχείριση των ψυχολογικών επιπτώσεων αυτών των κρίσεων.

Συνοψίζοντας, η εργασία κατέδειξε ότι η προστασία του περιβάλλοντος, η προαγωγή της βιωσιμότητας και η ενίσχυση των δομών ψυχικής υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι στόχοι. Οι περιβαλλοντικές αλλαγές δεν αποτελούν απλώς φυσικές προκλήσεις, αλλά και ψυχολογικές κρίσεις που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής και την κοινωνική συνοχή. Επομένως, η διασφάλιση ενός βιώσιμου και υγιούς μέλλοντος απαιτεί συντονισμένες και ολιστικές προσπάθειες που θα εστιάζουν τόσο στην προστασία του πλανήτη όσο και στη φροντίδα της ψυχικής υγείας των ανθρώπων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Journal of Clinical Psychiatry: "Impact of Natural Disasters on Mental Health: A Review", (2019).

Environmental Health Perspectives: "Noise Pollution and its Effect on Mental Health", (2020).

American Journal of Public Health: "Biodiversity and Mental Health: A Systematic Review", (2018).

Lancet Psychiatry: "Psychological Impact of Climate Change on Children and Adolescents", (2021).

Nature Communications: "Ecotherapy: Nature-Based Solutions for Mental Health", (2021).

WHO Publications (2005) Promoting Mental Health: Concepts, Emerging Evidence, Practice. " World Health Organization.

Herrman, H., Saxena, S., & Moodie, R. (2014). "Promoting Mental Health: Concepts, Emerging Evidence, Practice." *World Health Organization*.

Clayton, S., Manning, C. M., & Hodge, C. (2014). Beyond Storms and Droughts: The Psychological Impacts of Climate Change. American Psychological Association and ecoAmerica.

ΠΕΤΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (2017). Περιβάλλον και ψυχική υγεία: Διερεύνηση της επίδρασης του περιβάλλοντος στην εμφάνιση και θεραπεία ψυχικών νοσημάτων.

WHO, (2024). Depressive disorder (depression).

THE LANCET, (2021). Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic.

Nina Julia, 2023, (2023). Anxiety Statistics & Facts: How Many People Have Anxiety?

Clayton, S., Manning, C. M., Krygsman, K., & Speiser, M. (2017). Mental health and our changing climate: Impacts, implications, and guidance. American Psychological Association.

Steg, L., van den Berg, A. E., & de Groot, J. I. M. (Eds.). (2018). Environmental psychology: An introduction. John Wiley & Sons.

Lorenz, E. N. (1963). Deterministic nonperiodic flow. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 20(2), 130–141.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). APA DSM-5.

Bryant, R. A. (2016). Acute stress disorder: A handbook of theory, assessment, and treatment (2nd ed.). Guilford Press.

Bryant, R. A. (2017). Acute stress disorder. *Current Opinion in Psychology*, 14, 127-131.

Kearns, M. C., Ressler, K. J., Zatzick, D., & Rothbaum, B. O. (2012). Early interventions for PTSD: A review. *Depression and Anxiety*, 29(10), 833-842.

Roberts, N. P., Kitchiner, N. J., Kenardy, J., & Bisson, J. I. (2019). Systematic review and meta-analysis of multiple-session early interventions following traumatic events. *American Journal of Psychiatry*, 176(10), 915-923.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.

Yehuda, R., & LeDoux, J. (2007). Response variation following trauma: A translational neuroscience approach to understanding PTSD. *Neuron*, 56(1), 19-32.

Pitman, R. K., Rasmusson, A. M., Koenen, K. C., et al. (2012). Biological studies of post-traumatic stress disorder. *Nature Reviews Neuroscience*, 13(11), 769-787.

Cahill, S. P., Foa, E. B., Hembree, E. A., & Rauch, S. A. (2014). *Prolonged Exposure Therapy for PTSD: Emotional Processing of Traumatic Experiences*. Oxford University Press.

APA Dictionary of Psychology, (2023). Άρθρο από τον Οργανισμό Ψυχιατρικής Έρευνας (APA) για τις κλινικές πτυχές της διαταραχής προσαρμογής.

Sarah Vanbuskirk, 2023 “Solastalgia May Be the Reason Climate Change Is Making You Depressed”.

Albrecht, G. (2005). "Solastalgia: A new concept in human health and identity."

Warsini, S., Mills, J., & Usher, K. (2014). "Solastalgia: Living with the environmental damage caused by natural disasters." *Prehospital and Disaster Medicine*.

Harvard Health Publishing (2014). Generalized anxiety disorder.

- Beesdo, K., et al. (2009). "Generalized Anxiety Disorder: Patterns of Prevalence, Onset, Course, and Comorbidity." *Dialogues in Clinical Neuroscience*.
- Stein, M. B., & Sareen, J. (2015). "Generalized Anxiety Disorder." *New England Journal of Medicine*, 373(21), 2059-2068.
- Cuijpers, P., Karyotaki, E., Weitz, E., Andersson, G., Hollon, S. D., & Van Straten, A. (2021). The effects of psychotherapies for major depression in adults on remission, recovery and improvement: a meta-analysis. *World Psychiatry*.
- Ferrari, A. J., Charlson, F. J., Norman, R. E., et al. (2013). Burden of depressive disorders by country, sex, age, and year: findings from the global burden of disease study 2010. *PLOS Medicine*.
- Insel, T., & Cuthbert, B. (2015). Brain disorders? Precisely. *Science*, 348(6234), 499-500.
- Kessler, R. C., Berglund, P., Demler, O., et al. (2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. *Archives of General Psychiatry*, 62(6), 593-602.
- Klein, D. N., & Santiago, N. J. (2016). *Dysthymia and Chronic Depression: Assessment, Treatment, and Research*. American Journal of Psychiatry.
- Sullivan, P. F., Neale, M. C., & Kendler, K. S. (2000). Genetic epidemiology of major depression: Review and meta-analysis. *American Journal of Psychiatry*, 157.
- Gelenberg, A. J., et al. (2010). *Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder* (3rd ed.). American Psychiatric Association.
- Gaudiano, B. A., Young, D., & Chelminski, I. (2005). Psychotic features in major depression and their demographic and clinical correlates in adolescent inpatients. *Journal of Affective Disorders*, 86(1), 101-112.
- Zisook, S., & Shear, K. (2009). Grief and bereavement: what psychiatrists need to know. *World Psychiatry*, 8(2), 67-74.

Rosenthal, N. E., Sack, D. A., Gillin, J. C., Lewy, A. J., Goodwin, F. K., Davenport, Y., Mueller, P. S., Newsome, D. A., & Wehr, T. A. (1984). Seasonal affective disorder: A description of the syndrome and preliminary findings with light therapy. *Archives of General Psychiatry*, 41(1), 72-80.

Kendler, K. S., Gardner, C. O., & Prescott, C. A. (2006). Toward a comprehensive developmental model for major depression in women. *American Journal of Psychiatry*, 163(1), 115-124.

Markowitz, J. C., & Weissman, M. M. (2012). Interpersonal psychotherapy for depression: A meta-analysis. *American Journal of Psychiatry*, 169(6), 575-582.

Lisanby, S. H. (2007). Electroconvulsive therapy for depression. *The New England Journal of Medicine*, 357(19), 1939-1945.

Craske, M. G., & Barlow, D. H. (2007). Panic disorder and agoraphobia. In D. H. Barlow (Ed.), *Clinical Handbook of Psychological Disorders* (4th ed., pp. 1-64). New York: Guilford Press.

Roy-Byrne, P. P., Craske, M. G., & Stein, M. B. (2006). Panic disorder. *The Lancet*, 368(9540), 1023-1032.

Goodwin, R. D., & Hamilton, S. P. (2002). Panic attacks and panic disorder in the United States: Prevalence, correlates, and comorbidity. *Journal of Clinical Psychiatry*, 63(5), 494-499.

American Academy of Sleep Medicine. (2014). *International Classification of Sleep Disorders* (3rd ed.). Darien, IL: American Academy of Sleep Medicine.

Riemann, D., Spiegelhalder, K., Espie, C., et al. (2010). Chronic insomnia: Clinical and research challenges. *The Lancet*, 379(9821), 1129-1141.

Zee, P. C. (2010). Circadian rhythm sleep disorders. *Sleep Medicine Clinics*, 5(4), 601-615.

Punjabi, N. M. (2008). The epidemiology of adult obstructive sleep apnea. *Proceedings of the American Thoracic Society*, 5(2), 136-143.

Mahowald, M. W., & Schenck, C. H. (2005). Insights from studying human sleep disorders. *Nature*, 437(7063), 1279-1285.

Kryger, M., Roth, T., & Dement, W. C. (2017). *Principles and Practice of Sleep Medicine* (6th ed.). Philadelphia: Elsevier.

- Fairburn, C. G., & Harrison, P. J. (2003). Eating disorders. *The Lancet*, 361(9355), 407-416.
- Fairburn, C. G., Marcus, M. D., & Wilson, G. T. (2003). Cognitive-behavioral therapy for binge eating and bulimia nervosa: A comprehensive treatment manual. *Eating Disorders Review*, 11(1), 13-19.
- Hudson, J. I., Hiripi, E., Pope, H. G., & Kessler, R. C. (2007). The prevalence and correlates of eating disorders in the National Comorbidity Survey Replication. *Biological Psychiatry*, 61(3), 348-358.
- Kaye, W. H., Fudge, J. L., & Paulus, M. (2009). New insights into symptoms and neurocircuit function of anorexia nervosa. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(8), 573-584.
- Striegel-Moore, R. H., & Bulik, C. M. (2007). Risk factors for eating disorders. *American Psychologist*, 62(3), 181-198.
- Hay, P., Bacaltchuk, J., Stefano, S., & Kashyap, P. (2014). Psychological treatments for bulimia nervosa and binge. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Frone, M. R. (2016). Work stress and alcohol use: Developing and testing a biphasic self-medication model. *Work & Stress*, 30(4), 374-394.
- Jarrold, K., O'Farrell, A., & Lyons, S. (2021). Socioeconomic inequalities in alcohol-related harm in Europe: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(6), 1-12.
- Schulz, A. J., Mentz, G. B., Lachance, L., Johnson, J., Gaines, C., Israel, B. A., & Zenk, S. N. (2016). Associations between neighborhood characteristics and health behaviors: A multilevel analysis of diet and physical activity. *Health Education & Behavior*, 43(2), 175-184.
- Simons-Morton, B. G., Haynie, D. L., Crump, A. D., Eitel, P., & Saylor, K. E. (2016). Peer and parent influences on smoking and drinking behavior in early adolescents. *Health Education & Behavior*, 43(2), 132-140.
- Velleman, R., & Templeton, L. (2007). Understanding and modifying the impact of parental substance misuse on children. *Advances in Psychiatric Treatment*, 13(2), 79-89.
- Evans, E., Hawton, K., & Rodham, K. (2005). Suicidal phenomena and abuse in adolescents: A review of epidemiological studies. *Child Abuse & Neglect*, 29(1), 45-58.

Joiner, T. E., Van Orden, K. A., Witte, T. K., & Rudd, M. D. (2005). The interpersonal theory of suicide: Guidance for working with suicidal clients. American Psychological Association.

Nock, M. K., Borges, G., Bromet, E. J., Cha, C. B., Kessler, R. C., & Lee, S. (2008). Suicide and suicidal behavior. *Epidemiologic Reviews*, 30(1), 133-154.

Stack, S. (2000). Suicide: A 15-year review of the sociological literature part I: Cultural and economic factors. *Suicide and Life-Threatening Behavior*, 30(2), 145-162.

Blustein, D. L., Kozan, S., & Connors-Kellgren, A. (2013). Unemployment and underemployment: A narrative analysis about losing and finding meaningful work. *Journal of Vocational Behavior*, 82(3), 256-265.

Τζάκι Ντε Μπούρκα (Ιανουάριος, 2024). Constructive voices.